

群からの致死的不整脈の可能性に注意が必要である。

バイオ製剤：抗 IL-4 受容体 α 抗体療法は末梢血好酸球増多を伴う増悪コントロール不良例に対して増悪抑制と FEV₁ 改善などの有用性が示された^{5, 14, 15)}。末梢血好酸球増多を伴う頻回増悪症例に対して、処方可能である。

d 全身併存症と肺合併症への対応

全身併存症および肺合併症は COPD 患者の現状の悪化や将来リスクの増高をきたすことから、その予防と治療が必要である。全身併存症には、心血管疾患（虚血性心疾患、高血圧症、心不全、心房細動など）、骨粗鬆症、消化器疾患、抑うつなどがあり、それぞれの専門医との連携構築が必須である。また肺合併症には、肺高血圧症、肺炎、気胸、肺癌などがあり、それぞれの疾患ガイドラインに準拠した治療を考慮すべきである。

e 増悪期の管理

COPD の増悪とは、息切れの増加、咳や喀痰の増加、胸部不快感・違和感の出現あるいは増強などを認め、安定期の治療の変更あるいは追加が必要となる状態で、他疾患の先行が除外できた場合をいう。増悪は患者の QOL や呼吸機能を低下させ、生命予後を悪化させる。

i) 増悪期の薬物療法

COPD 増悪時の薬物療法の基本は ABC アプローチで、A (antibiotics)：抗菌薬、B (bronchodilators)：気管支拡張薬、C (corticosteroids)：副腎皮質ステロイド薬である。増悪時の第一選択薬は SABA の吸入である。安定期の病期がⅢ期以上や入院管理が必要な患者の増悪では、全身性ステロイド薬の投与（従来 prednisolone 30～40 mg/day を 10～14 日間だが、5 日間でも同等という報告もある）が勧められる。喀痰の膿性化があれば抗菌薬の投与が推奨される。

ii) 酸素療法および換気補助療法

酸素投与の目標は、PaO₂ 60 Torr 以上あるいは SpO₂ 90% 以上である。安定期からⅡ型呼吸不全を有

する症例では、過剰の酸素投与によって CO₂ ナルコーシスのリスクが高まるため、低濃度の酸素投与から開始する。PaCO₂ が 45 Torr を超え、かつ pH 7.35 未満の場合には換気補助療法の適応を検討する。

iii) 増悪の予防

非薬物療法および薬物療法を適正に組み合わせることで増悪を抑制できる⁵⁾。

f 予後

予後因子には、年齢、性別、喫煙、呼吸困難の程度、FEV₁、気腫病変の程度、低酸素血症の有無、肺高血圧症の有無、運動耐容能、身体活動性、栄養、増悪の頻度、全身併存症と肺合併症の有無などがある。適切な管理は健康寿命や平均寿命の延長、あるいは生命予後の改善が期待できる。

文 献

- 1) GBD 2021 Forecasting Collaborators: Lancet **403**: 2204, 2024
- 2) e-Stat: 人口動態調査. (<http://www.e-stat.go.jp/>)
- 3) Fukuchi Y, et al: Respirology **9**: 458, 2004
- 4) Koga Y, et al: Int J Chron Obstruct Pulmon Dis **19**: 1011, 2024
- 5) 日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会 (編): COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン, 第 6 版, メディカルレビュー社, 2022
- 6) Barr RG, et al: N Engl J Med **362**: 217, 2010
- 7) Nagata K, et al: Am J Respir Crit Care Med **206**: 1326, 2022
- 8) 喘息と COPD のオーバーラップ (Asthma and COPD Overlap: ACO) 診断と治療の手引き第 2 版作成委員会 (編): 喘息と COPD のオーバーラップ (Asthma and COPD Overlap: ACO) 診断と治療の手引き, 第 2 版, メディカルレビュー社, 2023
- 9) Decramer M, et al: Lancet **374**: 1171, 2009
- 10) Zhou Y, et al: N Engl J Med **377**: 923, 2017
- 11) Koarai A, et al: Respir Res **22**: 183, 2021
- 12) Koarai A, et al: Respir Investig **60**: 90, 2022
- 13) Zayed Y, et al: Clin Respir J **13**: 413, 2019
- 14) Bhatt SP, et al: N Engl J Med **389**, 205, 2023
- 15) Bhatt SP, et al: N Engl J Med **390**, 2274, 2024